



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN 2025

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN

Pedoman Pelayanan
Instalasi Rawat Jalan
Tahun 2025

Disusun oleh:
Kepala Instalasi Rawat Jalan



(dr. Riski Bagus Suhendra, Sp.DVE)

Disetujui Oleh :
Autorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP)

Ditetapkan oleh:
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(Heni Indra Wulansari, S.Kep.Ns.M.Kep)

TIM PENYUSUN

PENGARAH

1. Dr. dr. Aslichah , M.Kes. AFP

PENYUSUN

1. dr. Riski Bagus Suhendra, Sp.DVE
2. dr. Santoso Rahardjo, Sp.OG
3. dr. Rudi Priyo Utomo, Sp.OG
4. dr. Agung Wijaya Kusuma Sp.OG
5. dr. Muhammad Irawan, Sp.A
6. dr. Esti Purwaningrum, Sp.A
7. dr. Ratih Kusumawardani, Sp.A, M.Biomed
8. dr. Qashastia Sukma Paripurna Sp.A
9. dr. Cameleia Diah Setyorini, Sp.PD
10. dr. Heriyatmo, Sp.PD
11. dr. Dimas Aryo Pamungkas, Sp.PD
12. dr. Aditya Purwaka, Sp.PD
13. dr. Adhya Aji Pratama, Sp.PD
14. dr. Ardityo Rahmat Ardhany, Sp.PD-KGH
15. dr.Angga Prawira Purwanto, Sp.B
16. dr. Zaki Yamani, Sp.B
17. dr. Djanuar Fitriadi, Sp.B
18. dr. Arianto Prabowo, Sp.OT
19. dr. I Gede Made Oka Rahaditya, Sp.OT
20. dr. Fiski Purantoro, Sp.OT
21. dr. Fendi Fatkhurrohman Gozi, Sp.BS
22. dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp.N
23. dr. Aan Dwi Prasetyo, Sp.N
24. dr. Akhmad Zainul Arifin, Sp.N., M.Kes
25. dr. Rachmawati Wardani Sp.N
26. dr. Badariyatud Dini, Sp.BP-RE(K)
27. drg. Syafrini Farrahdebi
28. dr. Ferdyan Rachmat Efendi, Sp.U
29. dr. Novita Maulidiyah, Sp.P
30. dr. Fitri Indahyanti, Sp.P., MMRS
31. dr. Kristia Fahmi, Sp.P
32. dr. Maria Valentina Evelyn, Sp.JP
33. dr. Dion Setiawan Sp.JP
34. dr. Nurhadhi Sutanto, Sp.M
35. dr. N. Indra Bayu, Sp.M
36. dr. Latifah, Sp.M
37. dr. Julian Hertawan, Sp.T.H.T.K.L
38. dr. Fuad Fauzi, Sp.T.H.T.K.L
39. dr. Yekti Mumpuni, Sp.KJ
40. dr. Andika Widiati, Sp.KJ
41. dr. Erinda Rahma Mulia, Sp.KFR
42. dr. Eko Nugroho, Sp.KFR
43. dr. Tamara Aulia Fakhriinnisa
44. Bagas Surya Purwono Amd.Kep
45. S. Khilmin N., AMd.Kep
46. Selly M. P, AMd. Kep
47. Vira Agustin S, AMd.Kep
48. Irawati, AMd.Kep
49. Ns. Siti Julaihah S.Kep
50. Firdhausi N, AMd.Kep
51. Edo Vicky, S.Kep., Ns
52. Shara Wahyuni, AMd.Kep

-
53. Dimas Ragil A, AMd.Kep
 54. Rezza Anggela, S.Kep, Ns
 55. Selvia Leli A, S.Kep, Ns
 56. Aulia Rahmah, AMd.Keb
 57. Novi Lianti R, S.Keb.Bd
 58. Iin Widowati, Str.Keb
 59. Ana Nurul Firdausi, AMd.Kep
 60. Ns. Rita Amalia Karyow, S. Kep
 61. Yuyun Dianita, A.Md.Kep
 62. David Pamungkas Aprilindo, AMd. Kep
 63. Ns. Citra Intan Pratiwi, S.Kep
 64. Ns. Mega Cynthia Rahmawati, S.Tr.Kep
 65. Avita Maulidia, S.Kep., Ns
 66. Muhammad Rofi'ur Rutabi A.Md.Kep.Gi
 67. Ns. Mariatul Qiftiyah, S.Tr.Kep
 68. Istigosah, Amd. Kep
 69. Miati, AMd.Kep

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya Pedoman Instalasi Rawat Jalan dan Kesiambungan Pelayanan dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Pedoman Instalasi Rawat Jalan yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi sasaran keselamatan pasien, standar pelayanan berfokus pasien, standar manajemen rumah sakit, program nasional dan Integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan di rumah sakit.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Instalasi Rawat Jalan ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Pasuruan, 1 September 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Heni Indra Wulansari, S. Kep, Ns. M. Kep

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT HUSADA
NOMOR : 771.3/RSPHS/IPER/DIR/IX/2025**

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sebelumnya tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Jalan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Jalan
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
6. Peraturan BPJS kesehatan Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
7. Kepdirjen Nomor HK-02-02-D-47104-2024 tentang Instrument Survei Akreditasi Rumah Sakit
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang standar akreditasi rumah sakit
9. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43853/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit Kelas D Pratama
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
11. Kepkonsil No. 21A Th 2006 ttg Pengesahan Standar Kompetensi Dokter
12. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 935.4/RSPHS/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo;
13. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 (01 November 2025 hingga 31 Oktober 2026)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI RAWAT
JALAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- (2) Pedoman Pelayanan Instalasi dalam organisasi dan manajemen di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

**BAB II
RAWAT JALAN**

Pasal 2

- (1) Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan medis kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien dirawat inap
- (2) Sistem pendaftaran rawat jalan online menggunakan SIM-RS
- (3) Rekam medis selama rawat jalan dengan catatan terkini tersedia agar dapat mendukung serta bermanfaat untuk kesinambungan pelayanan Pasien
- (4) Setiap pasien yang datang ke Instalasi Rawat Jalan dibuatkan dokumen E-Rekam Medis
- (5) Pengisian dokumen E-Rekam medis jalan harus lengkap termasuk pengisian ringkasan rawat jalan.

Pasal 3

- (1) Di rawat jalan terdapat kepala ruang yang bertindak sebagai manajer pelayanan pasien
- (2) Pasien diskriming untuk kebutuhan pelayanan pasien
- (3) Kesinambungan dan koordinasi dapat dibuktikan di semua tingkat/fase asuhan pasien
- (4) Pasien rawat jalan yang membutuhkan asuhan yang kompleks atau diagnosis yang kompleks resume poliklinik dan tersedia untuk PPA
- (5) Terdapat kriteria pasien rawat jalan dengan asuhan atau diagnosis yang kompleks diperlukan ringkasan medis rawat jalan (resume poliklinik) yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan rumah Sakit

Pasal 4

- (1) Pengelolaan pasien rawat jalan yang menolak rencana asuhan medis termasuk keluar rumah sakit atas permintaan sendiri dan pasien yang menghendaki penghentian pengobatan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan
- (2) Terdapat peraturan untuk mengelola pasien yang meninggalkan rumah sakit tanpa pemberitahuan (melarikan diri)

-
- (3) Terdapat penatalaksanaan pasien rawat jalan dengan kebutuhan transportasi khusus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

Pasal 5

- (1) Persetujuan umum (*general consent*) diminta saat pertama kali pasien masuk rawat jalan dan didokumentasikan dalam E-Rekam medis
- (2) Pasien dan atau keluarga diminta untuk membaca, dan menandatangani persetujuan umum (*general consent*)
- (3) Pasien dan atau keluarga diminta untuk menandatangani persetujuan atau penolakan tindakan setiap ada rencana tindakan

Pasal 6

- (1) Pengkajian awal masing-masing pasien rawat jalan meliputi pemeriksaan fisik, riwayat kesehatan, pengkajian pasien dari aspek biologis, psikologis, sosial, ekonomi, kultural dan spiritual pasien
- (2) Pengkajian awal rawat jalan harus selesai dalam waktu 1 x 24 jam
- (3) Pelaksanaan pasien rawat jalan dengan penyakit akut /non kronis, asesmen awal diperbaharui setelah 1 (satu) bulan
- (4) Pelaksanaan pasien rawat jalan dengan penyakit kronis, Pengkajian awal diperbaharui setelah 3 (tiga) bulan
- (5) Semua pasien rawat jalan diskriminasi terhadap nyeri dan dilakukan pengkajian nyeri jika terdapat nyeri

Pasal 7

- (1) Pada pasien rawat jalan bila dilakukan tindakan diagnostik invasif/berisiko harus dilakukan pengkajian serta pencatatannya dalam E-Rekam Medis
- (2) Tersedia ruang pelayanan rawat jalan yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis.

Pasal 8

- (1) Pelayanan rawat jalan menyediakan pelayanan geriatri sesuai dengan tingkat jenis pelayanan di rumah sakit
- (2) Setiap pemeriksaan penunjang di Instalasi Rawat Jalan harus berdasarkan atas permintaan dokter
- (3) Untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi, setiap petugas wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan
- (4) Semua pasien yang berobat ke poli Paru wajib memakai masker
- (5) Pengumpulan spesimen dahak dilakukan tidak di lingkungan IRJA melainkan di rumah pasien, dan sputum dibawa ke RS beserta pengantar laboratorium dari dokter bila telah terkumpul

Pasal 9

- (1) Untuk pasien BPJS, tidak boleh ada kunjungan penunjang medik saat ada kunjungan dokter pada hari yang sama, kecuali pemeriksaan yang telah ditentukan oleh laboratorium dan tim verifikasi rawat jalan sebagai kontrol biaya
- (2) Setiap pasien dengan rencana operasi elektif harus berkoordinasi dengan Karu rawat jalan atau MOD (*Manager of duty*)

Pasal 10

- (1) Pasien rawat jalan dengan asuhan yang kompleks atau yang diagnosisnya kompleks diperlukan Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ)
- (2) Pasien rawat jalan yang memerlukan PRMRJ Adalah:
 - (a) Pasien dengan diagnosis kompleks
 - (b) Pasien dengan asuhan kompleks
- (3) Penyimpanan berkas PRMRJ sudah terdapat di E-Rekam medis pasien
- (4) Pelaksanaan pembuatan PRMRJ dievaluasi agar dapat memenuhi kebutuhan para DPJP serta untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien

Pasal 11

- (1) Pasien rawat jalan dengan diagnosa non kronis dalam berkunjung maksimal 2x kunjungan dalam 1 bulan.
- (2) Pasien dengan diagnosa kronis yang sudah dinyatakan stabil, maka pasien bisa dilakukan pengambilan obat saja tanpa bertemu dengan dokter (ITER) dan dilakukan PRB

Pasal 12

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan :

Ditetapkan di Pasuruan

Pada tanggal 1 September 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



Henri Indra Wulansari, S.Kep.Ns, M.Kep

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR : 771.3/RSPHS/IPER/DIR/IX/2025
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN
INSTALASI RAWAT JALAN

PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara optimal, merata, dan berkelanjutan. Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau.

Instalasi Rawat Jalan merupakan salah satu unit pelayanan utama di rumah sakit yang menjadi pintu masuk bagi sebagian besar pasien. Pelayanan rawat jalan berperan dalam memberikan diagnosis dini, pengobatan, serta tindak lanjut perawatan tanpa memerlukan perawatan inap. Selain itu, instalasi ini juga berfungsi sebagai penghubung pelayanan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan pasien dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan berkualitas, Instalasi Rawat Jalan dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanan melalui pengelolaan yang efektif dan efisien. Hal ini mencakup pengaturan alur pelayanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta pemanfaatan teknologi informasi seperti rekam medis elektronik sesuai dengan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

Selain itu, dalam rangka menjamin mutu dan keselamatan pasien, pelayanan di Instalasi Rawat Jalan harus mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit, termasuk penerapan sasaran keselamatan pasien dan peningkatan mutu berkelanjutan.

Dengan adanya pedoman pelayanan Instalasi Rawat Jalan, diharapkan seluruh tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan yang terstandar, profesional, dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan pasien, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit

1.2 Tujuan Pedoman

Tujuan Umum :

1. Memberikan acuan dalam penyelenggaraan pelayanan rawat jalan yang aman, berkualitas, efektif, efisien, dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan pasien sesuai dengan staf

Tujuan Khusus :

1. Menyeragamkan alur dan proses pelayanan rawat jalan di seluruh unit terkait.

-
2. Menjamin pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional (SPO), dan peraturan seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit .
 3. Meningkatkan pelayanan bersama melalui penerapan indikator saling dan evaluasi berkelanjutan.
 4. Meningkatkan kepuasan pasien melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah.
 5. Menjamin tertib administrasi dan dokumentasi pelayanan se Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
 6. Membantu pelaksanaan sistem referensi dan kesinambungan pelayanan kesehatan.
 7. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana).
 8. Menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan perbaikan

1.3 Ruang Lingkup Pelayanan

1. Ruang lingkup pelayanan klinik umum : memberikan pelayanan dengan lingkup yang terbatas yaitu pasien dengan diagnose yang ringan dan diperiksa oleh dokter umum
2. Ruang lingkup pelayanan klinik spesialis : memberikan pelayanan kepada pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut dengan dilayani oleh dokter spesialis
3. Ruang lingkup pelayanan gigi : memberikan pelayanan dengan lingkup terbatas yaitu pasien dengan diagnosis gigi dan diperiksa oleh dokter gigi

1.4 Batasan Operasional

1. Poli Umum dimana didalamnya mencakup pelayanan pemeriksaan dan penentuan diagnosis dan yang memeriksa adalah dokter umum
2. Poli Obsgyn dimana didalamnya mencakup pelayanan pemeriksaan kehamilan, konsultasi kandungan / alat kontrasepsi, penentuan diagnose, tindakan pemasangan dan pelepasan alat kontrasepsi IUD . Yang melayani adalah dokter spesialis obsgyn
3. Poli Bedah Umum dimana didalamnya mencakup pelayanan, pemeriksaan, penentuan diagnosa dan rawat luka. Dokter yang melayani adalah dokter spesialis bedah
4. Poli Penyakit Dalam dimana didalamnya mencakup pelayanan, pemeriksaan dan penentuan diagnosa. Dokter yang melayani adalah dokter spesialis penyakit dalam
5. Poli Anak dimana di dalamnya mencakup pelayanan, pemeriksaan, penentuan diagnose serta pelayanan imunisasi. Dokter yang melayani adalah dokter spesialis anak
6. Poli THT-KL dimana didalamnya mencakup pelayanan, pemeriksaan, penentuan diagnose. Dokter yang melayani adalah dokter spesialis THT-KL
7. Poli Mata dimana didalamnya mencakup pelayanan, pemeriksaan, penentuan diagnose dokter, Dokter yang melayani adalah dokter spesialis mata
8. Poli Paru dimana didalamnya mencakup pelayanan, pemeriksaan, penentuan diagnose, program TB DOTs. Dokter yang menangani adalah dokter spesialis paru
9. Poli Syaraf dimana didalamnya mencakup pelayanan, pemeriksaan, penentuan diagnose, pengobatan. Dokter yang melayani adalah dokter spesialis syaraf
10. Poli Orthopedi dimana didalamnya mencakup pelayanan pemeriksaan, penentuan diagnose, perawatan luka. Klinik ini akan dilayani oleh dokter spesialis orthopedi
11. Poli Kejiwaan dimana didalamnya mencakup pemeriksaan, pelayanan, konsultasi kejiwaan oleh dokter spesialis Kejiwaan

-
12. Poli Gigi umum dimana didalamnya mencakup pelayanan, pemeriksaan, penentuan diagnose, tindakan dan perawatan gigi yang akan dilayani oleh dokter gigi
 13. Poli Urologi dimana didalamnya mencakup kegiatan pelayanan, pemeriksaan, penentuan diagnose yang spesifik terutama masalah urologi. Dokter yang menangani adalah dokter spesialis urologi
 14. Poli Bedah Plastik dimana didalamnya mencakup kegiatan pelayanan, pemeriksaan, penentuan diagnose yang spesifik terutama masalah bedah plastik. Dokter yang menangani adalah dokter spesialis bedah plastik
 15. Poli Kulit dimana didalamnya mencakup pelayanan pemeriksaan, penentuan diagnose, perawatan luka. Klinik ini akan dilayani oleh dokter spesialis kulit
 16. Poli Rehab Medik dimana didalamnya mencakup kegiatan pelayanan, pemeriksaan, penentuan diagnose yang spesifik terutama masalah rehab medik. Dokter yang menangani adalah dokter fisioterapi dan rehabilitasi medik
 17. Poli Bedah syaraf dimana didalamnya mencakup kegiatan pelayanan, pemeriksaan, penentuan diagnose yang spesifik terutama masalah bedah syaraf. Dokter yang menangani adalah dokter spesialis bedah syaraf
 18. Poli Estetika dimana didalamnya mencakup pelayanan pemeriksaan, penentuan diagnose, perawatan kecantikan. Klinik ini akan dilayani oleh dokter spesialis kulit
 19. Poli jantung dimana didalamnya mencakup kegiatan pelayanan, pemeriksaan, penentuan diagnose yang spesifik terutama masalah jantung. Dokter yang menangani adalah dokter spesialis jantung.
 20. Poli dalam sub KGH dimana didalamnya mencakup kegiatan pelayanan, pemeriksaan, penentuan diagnose yang spesifik terutama masalah Ginjal dan Hipertensi. Dokter yang menangani adalah dokter spesialis dalam sub KGH
 21. Manajer Pelayanan Pasien di instalasi rawat jalan adalah Kepala ruang rawat jalan.

BAB II
STANDAR KETENAGAAN

- 2.1 Kualifikasi SDM
Sesuai dengan Kualifikasi ketenagaan SDM rumah sakit diatur secara teknis dalam Permenkes (terutama Permenkes No. 3 Tahun 2020), dan secara umum dalam UU Kesehatan serta UU Rumah Sakit.

Tabel 2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI FORMAL
A. Pelayanan Medik Dasar		
1	Dokter umum	Dokter umum
2	Dokter gigi	Dokter gigi
B. Pelayanan Medik Spesialis Dasar		
1	Penyakit dalam	Dokter Spesialis
2	Kesehatan anak	Dokter Spesialis
3	Neurologi	Dokter Spesialis
4	Bedah	Dokter Spesialis
5	Obstetri & Ginekologi	Dokter Spesialis
6	Cardiologi	Dokter Spesialis
7	Jiwa	Dokter Spesialis
8	Paru	Dokter Spesialis
9	Rehab Medik	Dokter Spesialis
C. Pelayanan Medik Spesialis Gigi dan Mulut		
1	Pedodonsi	Dokter Spesialis

- 2.2 Distribusi Ketenagaan

Tenaga di Rawat Jalan yang terkiбат di rumah sakit Prima Husada Sukorejo terdiri dari :

Tabel 2.2 Tenaga Instalasi Rawat Jalan

NO	NAMA JABATAN	WAKTU KERJA	JUMLAH SDM
A. Pelayanan Medik Dasar			
1	Dokter umum	Non shift	1
2	Dokter gigi	Non shift	1
B. Pelayanan Medik Spesialis Dasar			
1	Penyakit dalam	Non shift	6
2	Kesehatan anak	Non shift	4
3	Neurologi	Non Shift	4
4	Bedah	Non shift	15
5	Obstetri & Ginekologi	Non shift	3
6	Cardiologi	Non Shift	2
7	Jiwa	Non Shift	2
8	Paru	Non shift	3
9	Rehab Medik	Non Shift	2
C. Pelayanan Medik Spesialis Gigi dan Mulut			
1	Pedodonsi	Non shift	1

Sesuai dengan Standar Tenaga Keperawatan di RS Direktorat Keperawatan dan Keteknisian Medis Depkes,2005), penghitungan tenaga di rawat jalan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Standar Keperawatan Berdasarkan Depkes 2005

No	Nama Jabatan	Waktu Kerja	Definisi waktu Kerja	Jumlah SDM
1	Kepala Instalasi Rawat Jalan	Non shift	08.00-16.00	1
2	Perawat Pelaksana	7 shift	06.30 - 14.30 08.00 - 16.00 09.00 - 17.00 10.00 - 18.00 11.00 - 19.00 12.00 – 20.00 14.00 – 21.00	29

2.3 Pengaturan Jaga

Pengaturan Jaga di Instalasi Rawat jalan Rumah Sakit Prima Husada adalah sebagai berikut : (kondisi saat ini) nama jabatan disesuaikan dengan distribusi ketenagaan

Tabel 2.4 Pengaturan Jaga di Instalasi Rawat Jalan

NO	NAMA JABATAN	WAKTU KERJA	DEFINISI WAKTU KERJA	JUMLAH SDM
A. Pelayanan Medik Dasar				
1	Dokter umum	Non shift	-	1
2	Dokter gigi	Non shift	-	1
B. Pelayanan Medik Spesialis Dasar				
1	Penyakit dalam	Non shift	-	6
2	Kesehatan anak	Non shift	-	4
3	Neurologi	Non Shift		4
4	Bedah	Non shift	-	15
5	Obstetri & Ginekologi	Non shift	-	3
6	Cardiologi	Non shift	-	2
7	Jiwa	Non Shift		2
8	Paru	Non shift	-	3
9	Rehab Medik	Non shift	-	2
C. Pelayanan Medik Spesialis Gigi dan Mulut				
1	Pedodonsi	Non shift	-	1

Perhitungan Tenaga Keperawatan di Rawat Jalan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Perhitungan Tenaga Keperawatan di Instalasi Rawat Jalan

No	Nama Jabatan	Waktu Kerja	Definisi waktu Kerja	Jumlah SDM
1	Kepala Instalasi Rawat Jalan	Non shift	08.00-16.00	1
2	Perawat Pelaksana	7 shift	06.30 - 14.30 08.00 - 16.00 09.00 - 17.00	29

			10.00 - 18.00	
			11.00 - 19.00	
			12.00 – 20.00	
			14.00 – 21.00	

- Keterangan :
- 1. Shift pagi wajib mengikuti *Morning Breafing* (doa pagi) pukul 06.30 WIB
 - 2. Istirahat 1 jam
 - 3. Selesai shift wajib mengikuti *Daily Report*

BAB III
STANDAR FASILITAS

3.1 Denah Ruangan
Terlampir

3.2 Standar fasilitas

- 1. Letak ruang rawat jalan harus mudah diakses dari pintu masuk utama rumah sakit dan memiliki akses yang mudah ke ruang rekam medis, ruang farmasi, ruang radiologi, dan ruang laboratorium.
- 2. Ruang rawat jalan harus memiliki ruang tunggu dengan kapasitas yang memadai dan sesuai kajian kebutuhan pelayanan
- 3. Desain ruangan pemeriksaan pada ruang rawat jalan harus dapat menjamin privasi pasien.
- 4. terdapat ruangan pemeriksaan untuk pasien menular pada ruang rawat jalan, letak dan desain ruangan pemeriksaan untuk pasien menular harus dapat mengontrol penyebaran infeksi

Tabel 3.1 Persyaratan Ruangan di Instalasi Rawat Jalan

NO	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
1	Ruangan Administrasi	a) Luas ruangan disesuaikan dengan jumlah petugas, dengan perhitungan 3-5 m2/ petugas. b) Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Untuk ventilasi mekanik minimal total pertukaran c) udara 6 kali per jam . d) Intensitas cahaya minimal 100 lux.	RS Kelas C fungsi Informasi, registrasi, pembayaran dapat digabungkan pada satu ruangan
2	Ruangan Tunggu	a) Tiap tiap Klinik harus memiliki ruang tunggu tersendiri dengan kapasitas yang memadai. b) Luas ruang tunggu menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan dengan perhitungan 1-1,5 m2/orang. c) Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.	

NO	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		d) Ruang harus mengoptimalkan pencahayaan alami. e) Ruang tunggu dilengkapi dengan fasilitas desinfeksi tangan. f) Ruang tunggu untuk pasien penyakit menular harus dipisah dengan pasien tidak menular khususnya pasien anak dan kebidanan.	
4	Pos Perawat (<i>Nurse Station</i>)	Pos perawat harus disediakan fasilitas meja dan kursi untuk kebutuhan pendokumentasian.	
5	Ruangan Klinik (Konsultasi, Periksa/Tindakan)	a) Luas ruangan klinik 9-24 m ² dengan memperhatikan ruang gerak petugas, pasien dan peralatan. b) Disediakan wastafel dan fasilitas desinfeksi tangan. c) Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi. d) Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan/ sambungan langsung tanpa pengamanan arus. e) Ruang harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Untuk ventilasi mekanik minimal total pertukaran udara 6 kali per jam, untuk ventilasi alami harus lebih dari nilai tersebut. f) Ruang harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux. g) Untuk kelompok ruangan klinik penyakit menular harus dipisahkan dengan klinik penyakit tidak menular baik akses, alur maupun ruangnya.	

NO	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		h) Untuk ruangan klinik yang menangani pasien penyakit menular melalui udara (<i>airborne</i>), pertukaran udara minimal 12 kali per jam.	
6	Klinik Gigi	a) Luas ruangan klinik gigi 20-30 m ² dengan memperhatikan ruang gerak petugas, pasien dan peralatan. b) Disediakan wastafel dan fasilitas desinfeksi tangan. c) Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi. d) Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan kabel/kotak kontak tambahan. e) Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Untuk ventilasi mekanik minimal total pertukaran udara 6 kali per jam, untuk ventilasi alami harus lebih dari nilai tersebut f) Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux. g) Kompresor peralatan dental chair diletakkan di tempat yang aman dan getaran	Jumlah klinik menyesuaikan klasifikasi rumah sakit dan kajian kebutuhan pelayanan

NO	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
7	Klinik Kebidanan	a) Luas ruangan klinik kebidanan 16-30 m² dengan memperhatikan ruang gerak petugas, pasien dan peralatan. b) Disediakan wastafel dan fasilitas desinfeksi tangan. c) Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi. d) Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan/ sambungan langsung tanpa pengamanan arus. e) Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Untuk ventilasi mekanik minimal total pertukaran udara 6 kali per jam, untuk ventilasi alami harus lebih dari nilai tersebut f) Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami.	
8	Klinik Mata	a) Luas ruangan klinik mata 20-30 m² dengan memperhatikan ruang gerak petugas, pasien dan peralatan. Salah satu sisi ruangan harus mempunyai panjang >4 m. b) Disediakan wastafel dan fasilitas desinfeksi tangan. c) Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan kabel/kotak kontak tambahan. d) Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Untuk ventilasi mekanik minimal total pertukaran udara 6 kali per jam, untuk ventilasi alami harus lebih dari nilai tersebut.	Ada/tidak klinik mata dan jumlahnya klinik menyesuaikan klasifikasi rumah sakit dan kajian kebutuhan pelayanan

NO	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		e) Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. f) Untuk pencahayaan buatan dengan intense	
9	Klinik Jiwa	a) Luas ruangan klinik jiwa 12-24 m ² . b) Komponen bangunan harus mempunyai bentuk yang aman terhadap kemungkinan membahayakan pasien dan pengguna lainnya. c) Ruangan tunggu pasien dan akses terpisah dengan klinik lain. d) Disediakan wastafel dan fasilitas desinfeksi tangan. e) Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan/ sambungan langsung tanpa pengamanan arus. f) Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Untuk ventilasi mekanik minimal total pertukaran udara 6 kali per jam, untuk ventilasi alami harus lebih dari nilai tersebut. g) Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux	Ada/tidak klinik jiwa dan jumlahnya klinik menyesuaikan klasifikasi rumah sakit dan kajian kebutuhan pelayanan
10	Ruangan Laktasi	a) Letak berdekatan/ bersebelahan dengan klinik kebidanan dan penyakit kandungan. b) Disediakan wastafel di ruangan. c) Disediakan fasilitas tempat duduk dengan sandaran tangan. d) Disarankan tersedia meja bayi. e) Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara	

NO	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		baik alami maupun mekanik. Untuk ventilasi mekanik minimal total pertukaran udara 6 kali per jam, untuk ventilasi alami harus lebih dari nilai tersebut.	

BAB IV
KEMAMPUAN PELAYANAN DAN TATALAKSANA

Kemampuan Pelayanan Instalasi Rawat Jalan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Poli Bedah Umum
2. Pelayanan Poli Bedah Plastic
3. Pelayanan Poli Bedah Syaraf
4. Pelayanan Poli Urologi
5. Pelayanan Poli Orthopedi
6. Pelayanan Poli Anak
7. Pelayanan Poli Kandungan
8. Pelayanan Poli Syaraf
9. Pelayanan Poli Kulit dan Kelamin
10. Pelayanan Poli Telinga Hidung Tenggorok – Kepala Leher (THT-KL)
11. Pelayanan Poli Mata
12. Pelayanan Poli Jantung
13. Pelayanan Poli Paru
14. Pelayanan Poli Rehab Medik
15. Pelayanan Poli Kejiwaan
16. Pelayanan Poli Penyakit Dalam
17. Pelayanan Poli Kesehatan Gigi Anak
18. Pelayanan Poli Gigi Umum
19. Pelayanan Poli Estetika
20. Pelayanan Poli Umum
21. Pelayanan Poli MCU
22. Pelayanan Radiologi 24 jam
23. Pelayanan Laboratorium 24 jam
24. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang FNAB dan Patologi Anatomi

Tindakan yang dapat dilakukan di rawat jalan Adalah sebagai berikut :

1. USG 2D
2. USG 4D
3. USG vaskuler
4. Tindakan spirometri
5. Tindakan treatmill
6. Tindakan eksisi menggunakan hefyrcouter, Contoh : poli kulit
7. Tindakan circumsisi
8. Tindakan injeksi intraartikuler
9. Tindakan injeksi neurostimulator
10. Tindakan suntik haemorroid
11. ESWL
12. Tindakan audiometri

Pelayanan yang tidak bisa dilakukan di Instalasi Rawat Jalan

1. Pasien diagnosa carsinoma yang membutuhkan kemoterapi
2. Pasien rawat jalan gaduh gelisah yang membutuhkan terapi kejiwaan khusus
3. Pasien dengan diagnosa yg membutuhkan sub spesialis bedah

4.1 Pelayanan Pendaftaran

Petugas pendaftaran rawat jalan melakukan skrining pasien yang berkunjung ke poli atau ke dokter siapa, membantu mengisikan identitas pasien jika pasien baru berkunjung, dan petugas pendaftaran mengarahkan pasien ke farmasi untuk membeli masker untuk pasien yang akan berobat ke Poli Paru jika pasien / keluarga tidak memakai masker, petugas pendaftaran membantu untuk mencari kursi roda atau dragbar jika kondisi pasien tidak memungkinkan untuk berjalan. Petugas pendaftaran rawat jalan memanggil sesuai nomor antrian, mendaftarkan pasien di *billing* komputer, melengkapi form general concent di E - Rekam Medis jika pasien baru. Perawat dapat membantu untuk mencari kursi roda atau dragbar jika kondisi pasien tidak memungkinkan untuk berjalan.

Petugas Pendaftaran mengarahkan pasien untuk melakukan pembayaran jasa dokter pada kasir jika merupakan pasien dengan cara bayar UMUM. Jika pasien dengan cara bayar BPJS / Asuransi swasta, pendaftaran mengarahkan pasien langsung menunggu di depan poli tujuan.

4.2 Pelayanan Poli

Pasien dipanggil berdasarkan nomor antrian untuk masuk ke ruang pemeriksaan dokter. Dilakukan pengkajian awal medis dengan mengkaji riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik pasien, sedangkan pengkajian keperawatan mengkaji psikologis dan sosial ekonomi.

Semua pasien rawat jalan diskринing terhadap nyeri dan dilakukan pengkajian jika terdapat nyeri. Pengkajian nyeri pasien dewasa menggunakan Numeric Rating Scale, pada pasien yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyerinya dengan angka menggunakan asesmen Wong Baker FACES *Pain Scale*, pada pasien usia 1-3 tahun dapat digunakan asesmen nyeri menggunakan FLACC (*Face Lage Activity Cry Consolability Scale*). Untuk usia kurang dari 1 tahun dapat digunakan pengkajian nyeri dengan menggunakan NIPS (*Neonatal Infants Pain Scale*).

Dokter dan Perawat yang telah mendapatkan kewenangan klinis melaksanakan pengkajian awal sesuai dengan isi minimal pengkajian meliputi riwayat penyakit dan pemeriksaan fisik, mengkaji faktor fisik, psikologis, sosial dan ekonomi dan riwayat kesehatan pasien dimana pengkajian harus selesai sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan rumah sakit. Pengkajian awal medis dan keperawatan harus lengkap dalam waktu 1x24 jam

Sebelum melakukan tindakan pengkajian pasien, petugas kesehatan harus memperhatikan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi dengan melakukan handhygiene sebelum dan sesudah melaksanakan tindakan. Pengkjaian pasien juga harus memperhatikan hak-hak pasien seperti menjaga privasi pasien, menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien, menghormati nilai – nilai kerohanian pasien dan dapat mengidentifikasi nilai-nilai kepercayaan pasien

Hasil dari pengumpulan data klinis pengkajian awal yang meliputi masalah medis dan masalah keperawatan di analisa dan diintegrasikan sehingga muncul diagnosa. Hasil dari pengkajian pasien harus didokumentasikan dalam E-Rekam medis. Pelaksanaan pasien rawat jalan dengan penyakit akut /non kronis, pengkajian awal medis diperbaharui setelah 1 (satu) bulan. Pelaksanaan pasien rawat jalan dengan penyakit kronis, pengkajian awal medis diperbaharui setelah 3 (tiga) bulan

Penjadwalan kontrol dicetak di surat kontrol dan mengarahkan pasien untuk reservasi terlebih dahulu. Dokter menginput anamnesis, hasil pemeriksaan fisik, diagnosis, tindakan, permintaan laboratorium dan radiologi bila ada, kemudian memulangkan pasien di billing rawat jalan

4.3 Tata Laksana Pasien Umum

Pendaftaran pasien umum bisa secara langsung datang ke RS atau Reservasi ke CSO. Setelah reservasi, pasien datang ke pendaftaran untuk konfirmasi kedatangan, selanjutnya pasien melakukan pembayaran ke kasir untuk jasa dokter.

Pasien dipanggil berdasarkan nomor antrian, diperiksa dan dilakukan pengkajian awal medis pasien, muncul diagnosis dan pemberian resep. Setelah input resep, pasien diarahkan ke farmasi untuk pengambilan dan pembayaran ke kasir. Jika terdapat penunjang laboratorium atau foto rontgen, asisten menginput di billing, lalu pengantar penunjang di cetak, selanjutnya pasien diarahkan ke kasir untuk pembayaran. Bila ada pemeriksaan USG, dikondisikan ada atau tidaknya dokter radiologi, bila masih dalam jam prakteknya, pasien diarahkan ke kasir untuk pembayaran kemudian ke ruang USG. Bila tidak, ditawarkan pada pasien untuk pembayaran terlebih dahulu atau ditunda saat jam praktek dokter tersebut ada. Hasil pembacaan USG dapat dibawa pulang dan dikonsulkan pada DPJP saat control. Pemberian surat kontrol pada pasien umum, disesuaikan dengan kondisi pasien, karena tidak ada batasan kontrol.

4.4 Tata Laksana Pasien BPJS

Petugas pendaftaran depan melakukan skrining pasien yang berkunjung ke poli sesuai dengan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat 1 jika pasien menggunakan BPJS kesehatan. Bila pasien mempunyai asuransi kesehatan selain BPJS

Petugas pendaftaran rawat jalan memanggil sesuai nomor antrian, mendaftarkan pasien di *billing* computer, mencetak SEP (Surat Elegibilitas peserta) untuk peserta BPJS, Setelah terdaftar dan muncul di billing E-Rekam Medis, pasien diarahkan ke ruang tunggu. Pasien di panggil berdasarkan nomor antrian yang masuk untuk pemeriksaan sederhana yang terdiri dari pengkajian, tensi dan timbang berat badan. Selanjutnya pasien dipersilahkan menunggu untuk diperiksa dokter sesuai dengan antriannya. Setelah pasien diperiksa oleh dokter, jika pasien BPJS ada pemeriksaan penunjang seperti laboratorium maupun radiologi, tidak dapat dilakukan pada hari tersebut, kecuali beberapa pemeriksaan USG dan laboratorium tertentu yang telah disetujui oleh laboratorium dan verifikasi sebagai kontrol biaya. Perawat menjadwalkan kapan pemeriksaan untuk laboratorium atau rontgen. Perawat yang mengasistensi melihat kelengkapan memastikan kelengkapan berkas E-Rekam Medis dan membuat pengantar untuk kontrol termasuk penyakit kronis/ non kronis, rujuk Internal bila kolaborasi dengan dokter spesialis lain atau rujuk balik jika masa berlaku rujukan pasien telah habis atau pasien telah stabil dan di kembalikan ke faskes tingkat pertama. Untuk pasien yang mendapat resep, perawat menyerahkan resep ke instalasi farmasi dan memberi surat kontrol bila ada kontrol ulang.

Perawat poli bisa memberikan edukasi jika pasien terdapat keluhan tiba-tiba dan emergency dapat ke IGD sebelum tanggal kontrolnya. Rujuk internal digunakan pasien BPJS untuk kontrol ke poli lain yang masih dalam satu lingkup rumah sakit. Misalnya dari poli penyakit dalam ke poli syaraf dengan indikasi tertentu. Rujuk balik digunakan pasien BPJS apabila pasien telah selesai perawatan atau kondisi stabil, atau memberi pengantar pada faskes pertama

untuk merujuk kembali pasien tersebut karena pasien masih dalam perawatan. Rujuk balik diberikan dengan mengacu pada tanggal rujukan dan poli tujuan. Pasien dengan diagnosis kronis seperti DM, HT, CVA dan lainnya setelah perawatan 3 bulan di rumah sakit, harus dikembalikan ke faskes tingkat pertama. Rujuk balik untuk kontrol ulang diberikan karena dua kondisi yaitu pasien kontrol kedua setelah rawat inap, dan pasien yang telah mendapatkan rujuk internal satu kali dan masih membutuhkan control ulang pada dokter rujukan tersebut. Pemeriksaan laboratorium dan rontgen pasien BPJS wajib dijadwalkan minimal H+4. Kecuali beberapa pemeriksaan yang dilakukan saat itu juga sesuai dengan kebijakan dari tim verifikasi BPJS.

Kunjungan pasien fisioterapi dilakukan secara berkala sesuai dengan peraturan di rumah sakit. Kunjungan laboratorium dan kunjungan obat tetap terdaftar dalam billing pelayanan rawat jalan. Tindakan yang dapat dilakukan di rawat jalan pasien BPJS : tindakan stimulator injeksi, injeksi articular, tindakan spirometri, USG vaskuler, pelayanan treatmill sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Untuk pasien yang membutuhkan obat TB, dikomunikasikan dengan PIC TB poli untuk pencatatan dan pengadaan obat TB tersebut. Bila terjadi kekosongan dengan sebab apapun, pasien dirujuk ke faskes pertama atau diarahkan pada puskesmas yang mempunyai ketersediaan TB dengan melampirkan riwayat pengobatan pasien. Penginputan di billing harus sesuai dengan pengisian casemix.

4.5 Tata laksana Pasien Asuransi Non BPJS

Pasien dengan asuransi lain selain BPJS, pasien menyerahkan ID card, KTP atau tanda pengenal lain sesuai dengan yang tertulis di perjanjian kerjasama masing-masing asuransi. Untuk pemeriksaan dokter, tindakan, resep, pemeriksaan laboratorium dan rontgen dikoordinasikan dengan kasir untuk penjaminnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasien diarahkan ke apotik untuk pengambilan obat, diarahkan ke laboratorium atau rontgen bila terdapat tambahan pemeriksaan. Dokter mengisi form asuransi yang tersedia, dan perawat poli menyerahkan ke kasir. Pasien diarahkan ke kasir kembali untuk pengesahan kartu asuransi. Penjadwalan kontrol pasien asuransi tidak ada batasan seperti pasien BPJS, disesuaikan dengan kondisi pasien dan sesuai advice DPJP

4.6 Persetujuan Umum (General consent)

General Consent atau Persetujuan Umum adalah pernyataan kesepakatan yang diberikan oleh pasien terhadap peraturan rumah sakit yang bersifat umum, pernyataan dari pasien atau keluarga maupun seseorang yang diberi kuasa oleh pasien setelah diberikan penjelasan oleh petugas admisi. Persetujuan umum atau disebut juga *general consent* adalah persetujuan yang bersifat umum yang diberikan pasien pada saat masuk ruang rawat inap atau terdaftar pertama kali sebagai pasien rawat jalan. Persetujuan Umum Pelayanan Kesehatan (*General Consent for Treatment*) meliputi :

1. Pernyataan telah diberi penjelasan tentang hak dan kewajiban pasien.
2. Persetujuan terhadap :
 - a. Pemeriksaan Fisik yang dilakukan oleh Perawat dan Dokter;
 - b. Pemasangan alat kesehatan (kecuali yang membutuhkan persetujuan khusus);
 - c. Asuhan Keperawatan;
 - d. Pemeriksaan laboratorium, X-ray;
 - e. Pembiayaan/ Jaminan Kesehatan.

3. Pernyataan kesanggupan pembiayaan (tunai / jaminan)
4. Privasi dan kerahasiaan penyakit pasien kepada pihak lain.
5. Pernyataan tidak membawa barang berharga yang tidak diperlukan selama perawatan;
6. Pernyataan pasien harus :
 - a. Memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang keluhan sakit sekarang, riwayat medis yang lalu, medikasi/pengobatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesehatan pasien.
 - b. Mengikuti rencana pengobatan yang diadvikan oleh dokter, termasuk instruksi para perawat dan tenaga kesehatan yang lain sesuai perintah dokter.
 - c. Memperlakukan staf rumah sakit dan pasien lain dengan bermartabat dan hormat serta tidak melakukan tindakan yang akan mengganggu operasional rumah sakit.
 - d. Menghormati privasi orang lain dan barang milik orang lain dan rumah sakit;
 - e. Tidak membawa alkohol, obat-obatan terlarang atau senjata tajam ke dalam rumah sakit.
 - f. Menghormati bahwa Rumah Sakit adalah area bebas rokok.
 - g. Mematuhi jam kunjungan dari Rumah Sakit.
 - h. Meninggalkan barang berharga di rumah dan membawa hanya barang-barang yang penting selama tinggal di Rumah Sakit.
 - i. Memastikan bahwa kewajiban finansial atas asuhan pasien dipenuhi sebagaimana kebijakan Rumah Sakit.
7. Bertanggung jawab atas tindakannya sendiri apabila menolak pengobatan atau advis yang diberikan oleh dokter

4.7 Penundaan Keterlambatan Pelayanan

1. Pasien diberitahu jika ada penundaan dan kelambatan pelayanan antara lain akibat kondisi pasien atau jika pasien harus masuk dalam daftar tunggu. Penundaan pelayanan yang dapat terjadi di Rumah Sakit Prima antara lain :
 - a. Pemeriksaan Test Alergi di rawat jalan : penyebab : keterbatasan reagen
2. Pemeriksaan CT SCAN : CT Scan dilakukan di Rumah Sakit rujukan, karena Rumah Sakit Prima Husada belum memiliki CT Scan
3. Pasien diberitahu alasan penundaan dan kelambatan pelayanan dan diberi informasi tentang alternatif yang tersedia sesuai kebutuhan klinik pasien dicatat di rekam medis

4.8 Penolakan Rencana Asuhan Medis

Seorang pasien rawat inap atau rawat jalan telah selesai menjalani pemeriksaan lengkap dan sudah ada rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan, kemudian pasien ini memutuskan meninggalkan rumah sakit maka pasien ini dianggap sebagai pasien keluar menolak rencana asuhan medis. Pasien rawat inap dan rawat jalan (termasuk pasien dari unit darurat) berhak menolak tindakan medis dan keluar rumah sakit dengan melakukan tanda tangan penolakan.

Pasien ini menghadapi risiko karena menerima pelayanan atau tindakan tidak lengkap yang berakibat terjadi kerusakan permanen atau kematian. Jika seorang pasien rawat inap atau rawat jalan minta untuk keluar dari rumah sakit tanpa persetujuan dokter maka pasien harus diberitahu tentang risiko medis oleh dokter yang membuat rencana asuhan atau tindakan dan proses keluarnya pasien sesuai dengan regulasi rumah sakit. Jika pasien mempunyai dokter

keluarga maka dokter keluarga tersebut harus diberitahu tentang keputusan pasien. Bila tidak ada dokter keluarga maka pasien dimotivasi untuk mendapat/ mencari pelayanan kesehatan lebih lanjut. Harus diupayakan agar mengetahui alasan mengapa pasien keluar menolak rencana asuhan medis. Rumah sakit perlu mengetahui alasan ini agar dapat melakukan komunikasi lebih baik dengan pasien dan atau keluarga pasien dalam rangka memperbaiki proses

4.9 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Tuberkulosis

Rumah sakit melaksanakan program penanggulangan tuberkulosis di rumah sakit meliputi :

1. Promosi kesehatan;
2. Surveilans tuberkulosis
3. Pengendalian faktor risiko
4. Penemuan dan penanganan kasus tuberkulosis;
5. Pemberian kekebalan; dan
6. Pemberian obat pencegahan.

Rumah sakit menyiapkan sumber daya untuk penyelenggaraan pelayanan dan penanggulangan tuberkulosis. Rumah sakit menyediakan sarana dan prasarana pelayanan tuberkulosis sesuai peraturan perundang-undangan

Rumah sakit telah melaksanakan pelayanan tuberkulosis dan upaya pengendalian faktor risiko tuberkulosis sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penanggulangan tuberkulosis berupa upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif, preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecatatan atau kematian, memutuskan penularan mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat tubekulosis. Rumah sakit dalam melaksanakan penanggulangan tubekulosis melalui kegiatan yang meliputi:

1. Promosi kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan, pengobatan, pola hidup bersih dan sehat (PHBS) sehingga terjadi perubahan sikap dan perilaku sasaran yaitu pasien dan keluarga, pengunjung serta staf rumah sakit
2. Surveilans tuberkulosis, merupakan kegiatan memperoleh data epidemiologi yang diperlukan dalam sistem informasi program penanggulangan tuberkulosis, seperti pencatatan dan pelaporan tuberkulosis sensitif obat, pencatatan dan pelaporan tuberkulosis resistensi obat.
3. Pengendalian faktor risiko tuberkulosis, ditujukan untuk mencegah, mengurangi penularan dan kejadian penyakit tuberkulosis, yang pelaksanaannya sesuai dengan pedoman pengendalian pencegahan infeksi tuberkulosis di rumah sakit pengendalian faktor risiko tuberkulosis, ditujukan untuk mencegah, mengurangi penularan dan kejadian penyakit tuberkulosis, yang pelaksanaannya sesuai dengan pedoman pengendalian pencegahan infeksi tuberkulosis di rumah sakit.
4. Penemuan dan penanganan kasus tuberkulosis yang datang kerumah sakit, setelah pemeriksaan, penegakan diagnosis, penetapan klarifikasi dan tipe pasien tuberkulosis. Sedangkan untuk penanganan kasus dilaksanakansesuai tata laksana pada pedoman nasional pelayanan kedokteran tuberkulosis dan standar lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

5. Pemberian kekebalan dilakukan melalui pemberian imunisasi BCG terhadap bayi dalam upaya penurunan risiko tingkat pemahaman tuberkulosis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian obat pencegahan selama 6 (enam) bulan yang ditujukan pada anak usia dibawah 5 (lima) tahun yang kontak erat dengan pasien tuberkulosis aktif; orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang tidak terdiagnosa tuberkulosis; populasi tertentu lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Kunci keberhasilan penanggulangan tuberkulosis di rumah sakit adalah ketersediaan tenaga-tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi, prasarana, sarana dan manajemen yang handal

4.10 Pelayanan Geriatri

Pelayanan Geriatri diberikan kepada pasien Lanjut Usia dengan kriteria memiliki lebih dari satu penyakit fisik dan/atau psikis atau memiliki satu penyakit dan mengalami gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Selain pasien Lanjut Usia, pelayanan Geriatri juga diberikan kepada pasien dengan usia 70 tahun ke atas yang memiliki satu penyakit fisik dan/atau psikis

Jenis pelayanan Geriatri di RS prima Husada Sukorejo adalah ditingkat sederhana paling sedikit terdiri atas rawat jalan dan kunjungan rumah (home care). Pelayanan Lokasi pelayanan Geriatri berdekatan dengan ruang perawatan dan ruang Rehabilitasi Medik serta berdekatan dengan akses masuk Rumah Sakit :

1. Ruang pendaftaran / administrasi
2. Ruang tunggu
3. Ruang pemeriksaan
4. Ruang tim terpadu geriatrik

4.11 Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan/ kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui paduan intervensi medik, keterampilan fisik dan atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal.

Layanan fisioterapi adalah bentuk layanan kesehatan yang ditujukan pada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutik, dan mekanis), pelatihan fungsi, dan komunikasi.

Pelayanan rehabilitasi medik di RS prima Husada termasuk dalam pelayanan primer atau strata 1 (Rumah Sakit kelas C). Tenaga yang tersedia adalah dokter umum terlatih dan terapis (Fisioterapis/ Okupasi Terapi/ Perawat Rehabilitasi Medik). Di RS Prima Husada, tenaga yang tersedia adalah Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik (Sp.KFR) dan terapis. Tenaga keterampilan fisik adalah tenaga keterampilan lulusan D3 fisioterapi. Tugas fisioterapis adalah melakukan pengkajian dan terapi kepada pasien sesuai dengan kompetensi masing-masing dan arahan dokter dan bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaannya

Pasien rehab medik dapat berasal dari Instalasi Gawat Darurat, Rawat Jalan, Rawat Inap, konsul dari dokter praktek swasta/klinik atau pasien datang langsung ke poli fisioterapi. Kegiatan pelayanan rehab medik Adalah :

1. Pulih
2. Sembuh dengan gejala sisa

Persyaratan ruang fisioterapi Adalah

1. Lokasi

Lokasi gedung yang ideal terletak dekat ruangan rawat inap dan rawat jalan dengan memperhatikan kemudahan akses pasien difabel untuk mencapai Lokasi

2. Kebutuhan Ruang

Ruang fisioterapi cukup luas untuk penempatan tempat tidur, alat modalitas terapi, serta mobilitas kursi roda. Penyekat ruangan sebaiknya bukan pemisah permanen, misalnya tirai, folding door, untuk mempermudah pasien menggunakan kursi roda atau tempat tidur. Penyekat ini juga dimaksud agar ruangan mudah diperluas dan dapat dipakai kegiatan kelompok, Analisa jalan, dana tahu mengajar pada pasien

BAB V
LOGISTIK

Sesuai dengan PMK No.56 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit , peralatan yang dibutuhkan instalasi rawat jalan (*instrumen self assessment* izin operasional rumah sakit kelas tipe C) adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1

No	Nama alat	KELAS C
Klinik (Rawat Jalan) Pelayanan Penyakit Dalam		
1	Film Viewer	+
2	Examination Table/Meja Periksa/Tempat Tidur Periksa	+
3	Medical Flash Light/Pen Light	+
4	Stethoscope/Stetoskop	+
5	Sphygmomanometer Aneroid/ Tensimeter Anaeroid	+
6	Sphygmomanometer Digital/ Tensimeter Digital	+
7	Termometer digital	+
Klinik (Rawat Jalan) Pelayanan Bedah		
1	Stethoscope/Stetoskop	+
2	Meja Periksa/ Tempat tidur periksa/Examination Table	+
3	Pen Light/Medical Flash light	+
4	Refleks Hammer	+
5	TCD/Transcranial Doppler	+
6	Sphygmomanometer Aneroid/ Tensimeter Anaeroid	+
7	Sphygmomanometer Digital/ Tensimeter Digital	+
8	Head Lamp/Lampu Kepala	+
9	Lampu Periksa/Examination Lamp /Hanging Lamp	+
10	Termometer Digital	+
11	Film Viewer 2 slides	+
12	Alat pembuka gips (manual dan elektrik)	+
13	Suction Pump Portable/Aspirator/ Vacuum	+
Klinik (Rawat Jalan) Pelayanan Kesehatan Anak		
1	ECG	+
2	Infant dan baby pediatric resuscitation	+
3	Infant dan baby pediatric Stethoscope	+
4	Examination lamp	+

5	Syngmomanometer dengan manset untuk bayi dan anak	+
6	Infant dan baby weighting scale	+
7	Termometer rectal	+
8	Termometer axial	+
9	Reflex Hammer	+
10	cold chain : Kulkas Vaksin , Termos Portable	+
11	Vena section set	+
12	Baby Suction pump	+
13	Oxygen set dan flow meter	+
14	Nebulizer	+
Klinik (Rawat Jalan) Pelayanan Obstetri Dan Ginekologi		
1	Meja Periksa Kebidanan	+
2	Meja Periksa Ginekologi	+
3	Timbangan Dewasa	+
4	Tensimeter	+
5	Stetoskop	+
6	Doppler	+
7	Examination lamp	+
8	Gynecological Examination set	+
9	Pap Smear Kit	+
10	IUD kit	+
11	Implant kit	+
12	USG Transvaginal	+
13	USG 2 dimensi	+
14	Colposcopy	+
15	Forcep Biopsi	+
16	Stetoskop Laenec	+
17	Sterilisator portable	+
18	Cardiotocography	+
19	Minor surgery set	+
20	Office Histeroscopy	+
21	Suction pump	+
22	Utility trolley	+
23	Lemari obat kaca	+
24	Tromol kaca	+
25	ECG	+
26	Nierbekhen	+
27	Kursi Dorong	+
28	Standar Infus	+
29	Sonde uterus	+
30	Tampon Tang	+
31	Bak instrument kaca	+
32	Bak instrument	+

BAB VI KESELAMATAN PASIEN

6.1 Pengertian

Keselamatan Pasien (Patient Safety) adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem tersebut meliputi Asesmen resiko, Identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, Pelaporan dan analisis insiden, Kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, Implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko.

Sistem ini mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan dan tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil

6.2 Tujuan

1. Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit
2. Meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat
3. Menurunkan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) di rumah sakit
Terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)

6.3 Tata Laksana Keselamatan Pasien

1. Memberikan pertolongan pertama sesuai dengan kondisi yang terjadi pada pasien
2. Melaporkan pada Karu atau PJ shift
3. Menghubungi dokter jaga poli
4. Memberikan tindakan sesuai dengan instruksi dokter jaga
5. Mengobservasi keadaan umum pasien
6. Mendokumentasikan kejadian tersebut pada formulir "Pelaporan Insiden Keselamatan"

Standar Keselamatan pasien meliputi :

- a. Hak pasien
- b. Mendidik pasien dan keluarga
- c. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan
- d. Penggunaan metoda-metoda peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien
- e. Mendidik staf tentang keselamatan pasien
- f. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien

BAB VII KESELAMATAN KERJA

HIV / AIDS telah menjadi ancaman global. Ancaman penyebaran HIV menjadi lebih tinggi karena pengidap HIV tidak menampakkan gejala. Setiap hari ribuan anak berusia kurang dari 15 tahun dan 14.000 penduduk berusia 15 - 49 tahun terinfeksi HIV. Dari keseluruhan kasus baru 25% terjadi di Negara - negara berkembang yang belum mampu menyelenggarakan kegiatan penanggulangan yang memadai.

Angka pengidap HIV di Indonesia terus meningkat, dengan peningkatan kasus yang sangat bermakna. Ledakan kasus HIV / AIDS terjadi akibat masuknya kasus secara langsung ke masyarakat melalui penduduk migran, sementara potensi penularan dimasyarakat cukup tinggi (misalnya melalui perilaku seks bebas tanpa pelindung, pelayanan kesehatan yang belum aman karena belum ditetapkannya kewaspadaan umum dengan baik, penggunaan bersama peralatan menembus kulit : tato, tindik, dll).

Penyakit Hepatitis B dan C, yang keduanya potensial untuk menular melalui tindakan pada pelayanan kesehatan. Sebagai ilustrasi dikemukakan bahwa menurut data PMI angka kesakitan hepatitis B di Indonesia pada pendonor sebesar 2,08% pada tahun 1998 dan angka kesakitan hepatitis C dimasyarakat menurut perkiraan WHO adalah 2,10%. Kedua penyakit ini sering tidak dapat dikenali secara klinis karena tidak memberikan gejala.

Dengan munculnya penyebaran penyakit tersebut diatas memperkuat keinginan untuk mengembangkan dan menjalankan prosedur yang bisa melindungi semua pihak dari penyebaran infeksi. Upaya pencegahan penyebaran infeksi dikenal melalui “ Kewaspadaan Umum “ atau “Universal Precaution” yaitu dimulai sejak dikenalnya infeksi nosokomial yang terus menjadi ancaman bagi “Petugas Kesehatan”.

Tenaga kesehatan sebagai ujung tombak yang melayani dan melakukan kontak langsung dengan pasien dalam waktu 24 jam secara terus menerus tentunya mempunyai resiko terpajan infeksi, oleh sebab itu tenaga kesehatan wajib menjaga kesehatan dan keselamatan dirinya dari resiko tertular penyakit agar dapat bekerja maksimal.

Undang-undang No 36 tahun 2009 pasal 164 ayat (1) menyatakan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Rumah sakit adalah tempat bekerja yang termasuk kategori tersebut diatas, berarti wajib menerapkan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Program keselamatan dan kesehatan kerja ini bertujuan guna melindungi karyawan dan kemungkinan terjadinya kecelakaan di dalam atau di luar rumah sakit

Dalam Undang – Undang dasar 1945 pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa “ Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pekerjaan adalah pekerjaan yang bersifat manusiawi, yang memungkinkan pekerja ada dalam kondisi sehat dan selamat, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sehingga dapat hidup layak sesuai dengan martabat manusia

7.1 Tujuan

1. Petugas kesehatan didalam menjalankan tugas dan kewajibannya dapat melindungi diri sendiri, pasien dan masyarakat dari penyebaran infeksi.
2. Petugas kesehatan didalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai resiko tinggi terinfeksi penyakit menular dilingkungan tempat kerjanya, untuk menghindari paparan tersebut, setiap petugas harus menerapkan prinsip "*Universal Precaution*"

7.2 Tindakan yang Beresiko Terpajan

1. Cuci tangan yang kurang benar.
2. Penggunaan sarung tangan yang kurang tepat
3. Penutupan Kembali jarum suntik secara tidak aman
4. Pembuangan peralatan tajam secara tidak aman
5. Teknik dekontaminasi dan sterilisasi peralatan kurang tepat

7.3 Prinsip Keselamatan Kerja

Prinsip utama prosedur *Universal Precaution* dalam kaitan keselamatan kerja adalah menjaga *hygiene* sanitasi individu, higiene sanitasi ruangan dan sterilisasi peralatan. Ketiga prinsip tersebut dijabarkan menjadi 5 (lima) kegiatan pokok yaitu

1. Cuci tangan guna mencegah infeksi silang
2. Pemakaian alat pelindung diantaranya pemakaian sarung tangan guna mencegah kontak dengan darah serta cairan infeksi yang lain.
3. Pengelolaan alat kesehatan bekas pakai
4. Pengelolaan jarum dan alat tajam untuk mencegah perlukaan
5. Pengelolaan limbah dan sanitasi ruangan

BAB VIII PENINGKATAN MUTU

Prinsip dasar upaya peningkatan mutu pelayanan adalah pemilihan aspek yang akan ditingkatkan dengan menetapkan indikator, kriteria serta standar yang digunakan untuk mengukur mutu pelayanan Rumah Sakit yaitu:

8.1. Definisi Indikator

Indikator merupakan suatu variabel yang digunakan untuk bisa melihat perubahan. Indikator yang baik adalah yang sensitif tapi juga spesifik.

8.2. Kriteria

Spesifikasi dari indikator.

8.3. Standar

1. Tingkat performance atau keadaan yang dapat diterima oleh seseorang yang berwenang dalam situasi tersebut, atau oleh mereka yang bertanggungjawab untuk mempertahankan tingkat performance atau kondisi tersebut.
2. Suatu norma atau persetujuan mengenai keadaan atau prestasi yang sangat baik.
3. Sesuatu ukuran atau patokan untuk mengukur kuantitas, berat, nilai atau mutu.

Dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu pelayanan maka harus memperhatikan prinsip dasar sebagai berikut:

1. Aspek yang dipilih untuk ditingkatkan :
 - a. Keprofesian
 - b. Efisiensi
 - c. Keamanan pasien
 - d. Kepuasan pasien
 - e. Sarana dan lingkungan fisik
2. Indikator yang dipilih :
 - a. Indikator lebih diutamakan untuk menilai output daripada input dan proses
 - b. Bersifat umum, yaitu lebih baik indikator untuk situasi dan kelompok daripada untuk perorangan
 - c. Dapat digunakan untuk membandingkan antar daerah dan antar Rumah Sakit
 - d. Dapat mendorong intervensi sejak tahap awal pada aspek yang dipilih untuk di monitor
 - e. Didasarkan pada data yang ada
3. Kriteria yang digunakan
Kriteria yang digunakan harus dapat diukur dan dihitung untuk dapat menilai indikator, sehingga dapat sebagai batas yang memisahkan antara mutu baik dan mutu tidak baik.
4. Standar yang digunakan
Standar yang digunakan ditetapkan berdasarkan:

-
- a. Acuan dari berbagai sumber
 - b. Berdasarkan trend yang menuju kebaikan
 - c. *Benchmarking* dengan Rumah Sakit yang setara
5. Indikator mutu yang digunakan di IRJA adalah sebagai berikut :
- a. Angka keterlambatan dokter
 - b. Kejadian salah input resep
 - c. Kejadian petugas tertusuk jarum
 - d. Angka ketidaklengkapan pengisian formulir persetujuan/penolakan tindakan
 - e. Kejadian tidak dilakukannya penandaan pada pasien operasi 2 sisi (site marking)
 - f. Survei kepatuhan petugas dalam melakukan cuci tangan 5 moment
 - g. Survei pemahaman pasien terhadap risiko jatuh
 - h. Survei pemahaman staf terhadap evakuasi pasien
 - i. Survei pelaksanaan identifikasi pasien

BAB IX PENUTUP

Pada prinsipnya pelayanan instalasi rawat jalan adalah bagian pelayanan dari Rumah Sakit Prima Husada yang tidak hanya memberikan pelayanan berdasarkan pemenuhan target finansial saja, tetapi sebuah pelayanan yang mengedepankan akan kasih dan mengutamakan keselamatan pasien dengan cara meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan ataupun pelatihan - pelatihan. Diharapkan dengan terlaksananya pelayanan rawat jalan yang baik, akan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 1 September 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Heni Indra Wulansari, S.Kep.Ns, M.Kep